

CAPÍTULO 2.1

Angina Crónica

PERFIL EUNACOM 1.01.1.001
Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

En este artículo abordaremos la **angina crónica estable** y la **angina inestable**, dos condiciones clave en el manejo de la **Cardiopatía Isquémica**.

Angina Crónica Estable

La angina crónica estable es una manifestación de la **Enfermedad Coronaria** caracterizada por un patrón predecible de dolor torácico.

Clínica

Dolor torácico: *Típicamente aparece con el ejercicio y desaparece con el reposo.*

NOTA CLÍNICA

Es fundamental recordar que la presentación clínica puede variar. El dolor no siempre es torácico; puede manifestarse como opresión cardíaca, u otras sensaciones atípicas. La isquemia de la pared inferior miocárdica, por ejemplo, puede presentarse con dolor epigástrico.

Diagnóstico: Es **absolutamente clínico** y no requiere de ningún examen para establecerlo inicialmente.

Diagnóstico y Estudio Complementario

Aunque el diagnóstico inicial es clínico, se realizan exámenes para estratificar el riesgo y guiar el tratamiento.

- **Electrocardiograma (ECG) basal:** Se realiza primero. Si es normal, se procede al ECG de esfuerzo.
- **Test de Esfuerzo (Electrocardiograma de esfuerzo):** Es el **examen de elección y el más importante** para el manejo de la angina crónica.
- *Consiste en un ECG realizado durante ejercicio progresivo (ej. en caminadora).*
- Se considera positivo si aparecen signos de isquemia en el ECG, como **infradesnivel del segmento ST** o aplanamiento/inversión de la onda T. En este caso, el test se detiene.
- **Coronariografía:** Es el **examen de elección para decidir el tipo de tratamiento** de revascularización.

Equivalentes al Test de Esfuerzo (Imágenes de Esfuerzo)

Se utilizan cuando el ECG de esfuerzo no es interpretable o el paciente no puede realizar ejercicio físico.

Indicaciones: Bloqueo completo de rama izquierda (BCRI): Inutiliza la interpretación del ECG de esfuerzo. *Pacientes que no toleran o no pueden realizar la caminata (ej. amputados, en silla de ruedas, intolerancia al ejercicio).* **Tipos de imágenes de esfuerzo: Ecocardiografía de esfuerzo o ecocardiografía con dobutamina:** La dobutamina es un fármaco vasoactivo que genera esfuerzo farmacológico. **Cintigrafía de perfusión miocárdica (con esfuerzo o con dipiridamol):** El dipiridamol es un fármaco que acelera el corazón, generando también un esfuerzo farmacológico.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El **bloqueo completo de rama izquierda** es una indicación clave para **no** realizar un test de esfuerzo convencional.

Indicaciones de Revascularización

La coronariografía permite diferenciar el tipo de revascularización. Una vez confirmado que el paciente se beneficiará de la revascularización, la coronariografía guiará la elección entre angioplastia con stent o bypass coronario.

TABLA 2.1.1: TIPO DE REVASCULARIZACIÓN VS INDICACIONES

TIPO DE REVASCULARIZACIÓN	INDICACIONES
Angioplastia con Stent	- Afectación de uno o dos vasos (ej. descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha).
Bypass Coronario	- Afectación de tres vasos . - Afectación de dos vasos, incluyendo la arteria descendente anterior . - Afectación del tronco de la coronaria izquierda . - Afectación del ostium de la arteria coronaria (dificultad para instalar stent). - Obstrucción muy larga (impráctico colocar stent).

Sospecha de Otras Causas de Angina Crónica

Si el paciente con angina crónica presenta **soplo o síncope**, se debe sospechar de otras causas no puramente coronarias. **Posibles causas: Miocardiopatía Hipertrofica Estenosis Aórtica** Estudio: En estos casos, el examen inicial de elección es el **Ecocardiograma** para descartar valvulopatías o miocardiopatías antes de considerar el test de esfuerzo.

Manejo Farmacológico

El manejo de la angina crónica se centra en el control de los factores de riesgo cardiovascular y el alivio sintomático. **Medidas más importantes: Aspirina:** Es la medida más importante para prevenir el infarto en pacientes con enfermedad coronaria. **Estatina:** *Para el control de las dislipidemias.* Control de otros factores de riesgo (hipertensión, diabetes, tabaquismo, etc.). **Manejo del dolor: Nitroglicerina sublingual:** Utilizada para el alivio agudo de los síntomas, mientras se espera el tratamiento definitivo (stent o bypass).

Angina Inestable

La angina inestable es un **Síndrome Coronario Agudo** (SCA) y se diferencia de la angina crónica estable por sus características clínicas y su manejo.

Definición y Características

Se considera angina inestable en las siguientes situaciones: **Primer episodio de angina:** *Un paciente que nunca ha tenido angina y presenta dolor torácico con el esfuerzo que cede con el reposo.* **Angina de reposo:** El dolor anginoso ocurre sin esfuerzo físico. **Cambio en los síntomas:** *Un empeoramiento del patrón de angina preexistente, caracterizado por: Mayor frecuencia. Menor umbral de aparición (ej. aparece con menor esfuerzo). Mayor duración. Mayor intensidad.*

Importancia del Reconocimiento

Es fundamental diferenciar la angina inestable de la angina crónica estable debido a que: **Cambio en el estudio:** Requiere una evaluación y manejo diferentes. **Cambio en el manejo:** Se trata como un **Síndrome Coronario Agudo**.

Estudio y Manejo

Estudio inicial: Se realiza un **Electrocardiograma** de inmediato. * **Manejo:** Se maneja según el protocolo de **Síndrome Coronario Agudo** (SCA), diferenciando si hay o no supradesnivel del ST.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La angina estable se maneja con un test de esfuerzo y revascularización electiva, mientras que la angina inestable es un síndrome coronario agudo y requiere manejo de urgencia.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

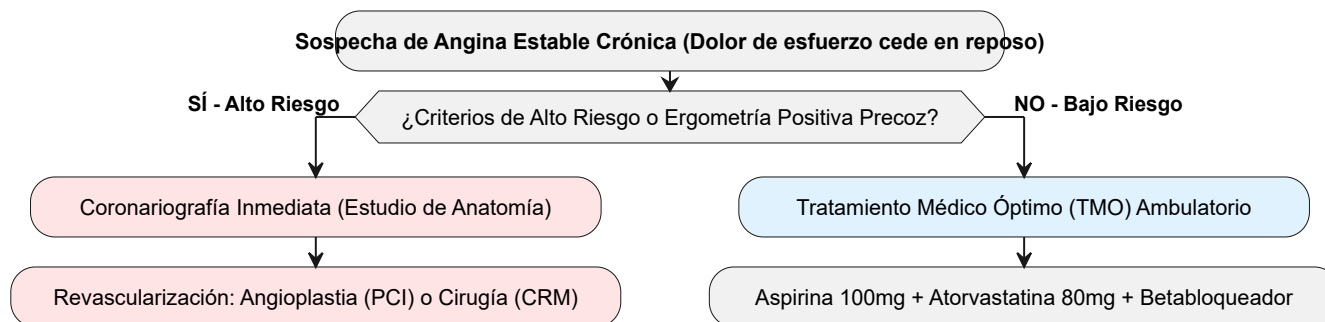
"Hombre de 64 años, diabético, presenta dolor opresivo al caminar 2 cuadras que cede en 5 min de reposo. Test de esfuerzo (+)."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Angina Estable Crónica. Tratamiento médico óptimo: Aspirina 100mg + Atorvastatina 80mg + Betabloqueador. Coronariografía si test de alto riesgo.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La angina crónica estable cede con reposo en menos de 10 minutos
- Los betabloqueadores son primera línea de tratamiento antiisquémico
- Todo paciente con angina crónica debe recibir aspirina y estatinas
- La ergometría es el estudio inicial en probabilidad pretest intermedia
- La enfermedad de tronco común izquierdo tiene indicación de revascularización
- La clasificación CCS gradúa la limitación funcional de I a IV
- Los nitratos alivian el dolor agudo pero no mejoran el pronóstico

FIGURA 2.1B: ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ANGINA ESTABLE CRÓNICA**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANGINA CRÓNICA)****PREGUNTA 1**

Hombre de 62 años, hipertenso y dislipidémico, consulta por dolor torácico opresivo con esfuerzo moderado que cede en 5 minutos con reposo. ECG basal normal. ¿Cuál es el estudio diagnóstico inicial más adecuado?

- ☐ A) Coronariografía
- ☐ B) Test de esfuerzo (ergometría)
- ☐ C) AngioTC coronario
- ☐ D) Ecocardiograma en reposo
- ☐ E) Holter de arritmias

PREGUNTA 2

Paciente con angina crónica estable y coronariografía que muestra estenosis del 70% del tronco común izquierdo. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ A) Tratamiento médico óptimo y control
- ☐ B) Revascularización coronaria
- ☐ C) Repetir coronariografía en 6 meses
- ☐ D) Stent farmacológico sin cirugía
- ☐ E) Iniciar nitratos y reevaluar

PREGUNTA 3

Paciente con angina crónica estable CCS II. ¿Cuál es el fármaco antiisquémico de primera línea?

- ☐ A) Nitroglicerina sublingual
- ☐ B) Amlodipino
- ☐ C) Betabloqueador
- ☐ D) Nitratos de acción prolongada
- ☐ E) Ivabradina

RESUMEN: ANGINA CRÓNICA

La angina crónica estable es la manifestación clínica de isquemia miocárdica por enfermedad coronaria obstructiva crónica. Se presenta como dolor torácico opresivo, retroesternal, desencadenado por esfuerzo físico o estrés emocional, que cede con reposo o nitroglicerina sublingual en menos de 10 minutos. La clasificación funcional de la Canadian Cardiovascular Society (CCS) gradúa la severidad del I al IV. El diagnóstico se basa en la historia clínica y la demostración de isquemia. La ergometría o test de esfuerzo es el estudio inicial en pacientes con probabilidad pretest intermedia que pueden realizar ejercicio y tienen ECG basal interpretable. Alternativas incluyen ecocardiograma de estrés, cintigrafía miocárdica con estrés y angioTC coronario. La coronariografía es el gold standard anatómico. El tratamiento incluye manejo de factores de riesgo cardiovascular, terapia antiisquémica con betabloqueadores como primera línea, nitratos y calcioantagonistas. Todo paciente debe recibir aspirina y estatinas. La revascularización se indica en enfermedad de tronco común izquierdo, enfermedad de tres vasos con disfunción ventricular, o angina refractaria a tratamiento médico óptimo. La revascularización puede ser percutánea con stent o quirúrgica con bypass.